

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1451

1 de septiembre de 2026

Presentado por la señora *Santiago Negrón* y el señor *González Costa*

Referido a la Comisión de

LEY

Para enmendar la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de requerir a todas las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud establecidas conforme a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, así como a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y a cualquier entidad contratada para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico a través de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, proveer, como parte de su cubierta básica y beneficios mínimos, las cirugías para tratar el *pectus carinatum*, el *pectus excavatum* y cualquier otra deformidad de la pared torácica; y para decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El *pectus carinatum* es una desviación de la posición y proporción típica de la pared torácica en la que el esternón y las costillas se desplazan hacia afuera. Esta afección ocurre en aproximadamente uno de cada mil nacimientos, y se presenta con mayor frecuencia entre los niños que entre las niñas.¹ El *pectus carinatum* suele agravarse a medida que la

¹ El promedio de nacimientos totales en Puerto Rico entre el 2020 y el 2024 fue de 18,831 al año. Eso permite proyectar la cantidad de casos de *pectus carinatum* a aproximadamente 19 casos por año. En Estados Unidos, sólo el 21% de las pacientes afectadas terminó requiriendo cirugía. Esto representaría cerca de 4 casos al año en Puerto Rico.

Véase, Edward KR, John OR, Jay GM, Ann KM, Mary MM, Stopp DD, Khrisna PH, Woodrow FF. *Ten-year experience with staged management of pectus carinatum: Results and lessons learned*. J Pediatr Surg. 2021 Oct;56(10):1835-1840. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2021.01.027. Epub 2021 Jan 27. PMID: 33558070.

persona crece, especialmente durante la pubertad, resultando en el desarrollo de escoliosis en cerca del 15% de los casos. Con frecuencia, el desplazamiento es asimétrico, por lo cual un lado del pecho suele ser más prominente que el otro. En situaciones más complejas, algunas personas presentan *pectus carinatum* en un lado del pecho y una depresión denominada *pectus excavatum* en el otro.² En el 95% de los casos la parte media e inferior del esternón sobresale hacia adelante. Esa variación se conoce como prominencia condrogliolar. Mientras, la prominencia condromanubrial, o *pectus arcuatum*, es un tipo poco frecuente en la que la parte superior del esternón sobresale y la parte inferior está hundida.

Las personas con *pectus carinatum* tienen un mayor riesgo de presentar trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos; pueden experimentar dolor durante la actividad física; y, en ocasiones, ven afectado el funcionamiento adecuado del corazón a causa de la estructura inusual de la pared torácica. A su vez, la carga psicosocial, que incluye una autoimagen corporal deteriorada y ansiedad social, es significativa entre adolescentes y adultos jóvenes con *pectus carinatum* y *pectus excavatum*. Ésta se manifiesta a menudo mediante aislamiento social, conductas de ocultamiento y malestar emocional.³ Consecuentemente, las pacientes con estas afecciones suelen presentar una menor calidad de vida, tanto con relación a la salud física como en el ámbito mental.⁴ Afortunadamente, el tratamiento quirúrgico de las deformidades de la pared torácica mejora notablemente la autoimagen corporal, la autoestima, la participación social y los indicadores de salud mental, con beneficios que se mantienen a largo plazo.⁵

² La cifra documentada de casos de *pectus excavatum* en Estados Unidos es de aproximadamente un caso por cada mil nacimientos. Esto equivaldría en Puerto Rico a aproximadamente 19 casos al año.

Véase, Girish Sharma; Yvonne M. Carter, *Pectus Excavatum*. National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430918/?utm_source=chatgpt.com. February 15, 2026.

³ Barmash EA, Mathai BB, Mansfield SA, Van Arendonk KJ. *Psychological Impact of Congenital Chest Wall Deformities Among Adolescents and Young Adults*. Children (Basel). 2026 Feb 7;13(2):237. doi: 10.3390/children13020237. PMID: 41749593; PMCID: PMC12939798.

⁴ Steinmann C, Krille S, Mueller A, Weber P, Reingruber B, Martin A. *Pectus excavatum and pectus carinatum patients suffer from lower quality of life and impaired body image: a control group comparison of psychological characteristics prior to surgical correction*. Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Nov;40(5):1138-45. doi: 10.1016/j.ejcts.2011.02.019. Epub 2011 Mar 25. PMID: 21440452.

⁵ Barmash EA, et al., *supra*, n. 3.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

4 “ARTÍCULO VI. – PLAN DE SEGUROS DE SALUD

7 . . .

Sección 6. – Cubierta y Beneficios Mínimos.

Los planes de salud tendrán una cubierta amplia, con un mínimo de exclusiones. No habrá exclusiones por condiciones preexistentes, como tampoco períodos de espera, al momento de otorgarse la cubierta al beneficiario.

Cubierta A. La Administración establecerá una cubierta de beneficios a ser brindados por los aseguradores contratados o proveedores participantes. La cubierta comprenderá, entre otros beneficios, los siguientes: servicios ambulatorios, hospitalizaciones, salud dental, salud mental, estudios, pruebas y equipos para beneficiarios que requieran el uso de un ventilador para mantenerse con vida, laboratorios, rayos X, *cirugías para tratar el pectus carinatum, el pectus excavatum y cualquier otra deformidad de la pared torácica de conformidad con el criterio clínico*, así como medicamentos mediante prescripción médica, los cuales deberán ser despachados en una farmacia participante, libremente seleccionada por el asegurado, y autorizada bajo las Leyes de Puerto Rico. La cubierta dispondrá para que cada beneficiario tenga a su alcance anualmente los exámenes de laboratorio e inmunización apropiados para su edad, sexo y condición física. Disponiéndose que la lista de medicamentos para los pacientes de VIH/SIDA deberá[n] revisarse anualmente a los fines de, en caso de que la Administración lo estime pertinente, incluir aquellos nuevos medicamentos que sean

1 necesarios para el tratamiento de la condición que serán dispensados y
2 ofrecidos en conformidad con las mejores prácticas médicas, siempre y
3 cuando no se afecte el “State Plan” suscrito por el Departamento de Salud
4 y el “Health Resources and Services Administration”.

5 La Administración revisará esta cubierta periódicamente.

6 Cubierta B. ...

7 Cubierta C. ...

8 Sección 7. - ...

9 ...

10 Sección 19. - ...”

11 Artículo 2.- Cláusula de supremacía.

12 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de
13 ley, reglamento o norma que no estuviere en armonía con ellas.

14 Artículo 3.- Cláusula de separabilidad.

15 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
16 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la
17 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de
18 dictamen adverso.

19 Artículo 4.- Cláusula de vigencia.

20 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.